

表1 医薬品副作用被害救済制度の救済給付の対象とならない場合

1. 医薬品等の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合。
2. 医薬品等の副作用において、健康被害が入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が経過した場合。
3. 対象除外医薬品による健康被害の場合（抗癌薬、免疫抑制薬などの一部は対象除外医薬品）。
4. 医薬品等の製造販売業者などに明らかに損害賠償責任がある場合。
5. 救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用し、健康被害の発生があらかじめ認識されていたなどの場合。
6. 法定予防接種を受けたことによるものである場合（この場合は予防接種健康被害救済制度あり）。なお、任意に予防接種を受けた場合は対象となる。

[<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> (2019年7月11日閲覧)]

表2 「医療に起因する（疑いを含む）」死亡又は死産の考え方

「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」を、医療事故として管理者が報告する。

「医療」（下記に示したもの）に起因し、 又は起因すると疑われる死亡又は死産（①）	①に含まれない死亡又は死産（②）
○診療 - 徴候、症状に関連するもの ○検査等（経過観察を含む） - 検体検査に関連するもの - 生体検査に関連するもの - 診断穿刺・検体採取に関連するもの - 画像検査に関連するもの ○治療（経過観察を含む） - 投薬・注射（輸液含む）に関連するもの - リハビリテーションに関連するもの - 処置に関連するもの - 手術（分娩含む）に関連するもの - 麻酔に関連するもの - 放射線治療に関連するもの - 医療機器の使用に関連するもの ○その他 以下のような事案については、管理者が医療に起因し、又は起因すると疑われるものと判断した場合 - 療養に関連するもの - 転倒・転落に関連するもの - 誤嚥に関連するもの - 患者の隔離・身体的拘束/身体抑制に関連するもの	左記以外のもの 〈具体例〉 ○施設管理に関連するもの - 火災等に関連するもの - 地震や落雷等、天災によるもの - その他 ○併発症 （提供した医療に関連のない、偶発的に生じた疾患） ○原病の進行 ○自殺（本人の意図によるもの） ○その他 - 院内で発生した殺人・傷害致死、等

※1 医療の項目には全ての医療従事者が提供する医療が含まれる。

※2 ①、②への該当性は、疾患や医療機関における医療提供体制の特性・専門性によって異なる。

[<https://www.medsafe.or.jp/modules/about/> (2019年7月11日閲覧)]

療行為を行ううえで、医療事故としての対応も周知しておく必要がある。

医療事故調査制度²⁾は、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関（医療事故調査・支援センター）が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組みである。2014年6月18日に成立した医療法の改正に盛り込まれ、2015年10月1日より施行されている。日本呼吸器学会は医療事故調査等支援団体のひとつである（平成27年8月6日付厚生労働省告示第343号）。医療法上、本制度の対象となる医療事故は、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予

期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの」とされている（表2）。病院、診療所または助産所の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない（医療法第6条の10）。

医療事故調査の流れを図2に示す。医療事故発生時の遺族への説明としては、表3に示す内容が定められている（平成27年5月8日医政発0508第1号）。なお、医療法では、医療事故に該当するかどうかの判断と最初の報告は、医療機関の管理者が行うことと定められており、遺族が「医療事故」として医療事故調査・支援センターに報告する仕組みとはなっていない。この「医療事故」か否かの判断に対して、遺族な